Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul

Rua Ernesto Alves, 945 - Bairro: Centro - CEP: 96810144 - Fone: (51) 3098-5791 - Balcão Virtual: (51) 995120095 - Email: frsantcruz1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000073-41.2023.8.21.0026/RS

AUTOR: SERGIO PEDRO GOETTERT

RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

Vistos.

SERGIO PEDRO GOETTERT, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de **UNIMED NACIONAL**, igualmente qualificada. Aduziu que mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a Ré, tendo sido diagnosticado como sendo portador da patologia classificada no CID-10 com o código J84.1 (Outras Doenças Pulmonares Intersticiais com Fribose - Fribose Pulmonar Idiopática), apresentando distúrbio ventilatório restritivo, progressão sintomática recente, dispneia (falta de ar) aos mínimos esforços e piora da qualidade de vida, necessitando assim, de uso contínuo do medicamento nintedanibe (Ofev), na dose de 150 mg duas vezes ao dia, devendo ser iniciado com urgência e mantido por tempo indeterminado. Alegou que a referida medicação é imprescindível para o requerente, eis que com a medicação pode apresentar arrefecimento no curso de sua doença e redução do risco de exacerbações, incluído o risco de vida. Referiu que em razão do alto custo da medicação, não possui condições financeiras de adquirir o medicamento. Relatou ter solicitado administrativamente o medicamento junto à demandada, e que mesmo com a prescrição médica, o plano de saúde recusou tal pretensão, não apresentando qualquer justificativa para tal negativa. Discorreu acerca do direito que lhe assiste. Requereu, em tutela de urgência, ordem para que a ré forneça imediatamente o medicamento. Em definitivo, requereu a procedência da ação, com a condenação da ré ao fornecimento do fármaco solicitado. Postulou o benefício da AJG, o que foi deferido. Juntou documentos (evento 1).

O pedido de tutela de urgência foi deferido (evento 5), tendo a parte ré interposto recurso de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, revogando a liminar (evento 39).

Citada, a ré apresentou contestação. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa. Discorreu acerca das razões de improcedência da demanda. Argumentou que em se tratando de contrato válido e eficaz, firmado na forma prevista em lei por agentes capazes e com objeto lícito, legítima é a negativa. Referiu que no caso dos autos, de acordo com o Anexo II da RN 465/2021, o medicamento solicitado pela parte autora destina-se aos casos de câncer de pulmão (CPNPC), ou seja, patologia diferente daquela suportada pelo demandante, sendo, portanto, correta a negativa de cobertura. Sustentou que considerando que não há evidência científica para cobertura do medicamento NINTEDANIBE (OFEV) para a patologia suportada pela parte autora, bem como que não há cobertura por não constar no Rol da ANS, evidentemente o caso em tela deve ser julgado improcedente. Dissertou sobre a mitigação do CDC quanto à inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (evento 17).

Houve réplica (evento 23).

Despacho saneador (evento 28).

Realizada audiência de instrução, foi inquirida uma testemunha. Na sequência, foi declarada encerrada a instrução (evento 64).

As partes apresentaram memoriais (eventos 70 e 72).

Instado, o MP declinou de intervir no feito (evento 75).

Vieram os autos conclusos para sentença.

RELATEI.

DECIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora pretende a condenação da ré ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev), que lhe fora prescrito por seu médico assistente, para a patologia que lhe acomete.

Com efeito, a parte autora é portadora da patologia classificada no CID-10 com o código J84.1 (Outras Doenças Pulmonares Intersticiais com Fribose - Fribose Pulmonar Idiopática), e em razão da doença, lhe fora prescrito o tratamento com a utilização da medicação Nintedanibe (Ofev), na dose de 150 mg duas vezes ao dia, conforme evento 1-LAUDO8.

Desse modo o autor, que possui plano de saúde junto à ré, solicitou o custeio do tratamento, o qual restou negado.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que incidem à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, §2º devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 469, assim redigida:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

Há que se destacar, portanto, que no caso em exame, por se tratar de relação de consumo, entendo pela aplicabilidade do art. 47[1] do CDC, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Desta feita, concluo que, frente as peculiaridades do caso posto em análise, a negativa ao fornecimento do medicamento, fármaco esse necessário e indicado para o tratamento da doença que acometera o autor, importa na negativa do previamente avençado, pois a doença que acomete o demandante tem CID especificado, constando, porquanto, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionado à Saúde da OMS, cujas coberturas são garantidas pela Lei 9.656/98, regras as quais o demandado afirma se submeter.

Outrossim, há de se destacar que o medicamento Nintedanibe (Ofev) está registrado na ANVISA.

Gize-se, ainda, que a despeito do uso domiciliar do fármaco ora requerido, tem-se como devida a cobertura postulada, sobretudo porquanto concernente a medicamento recomendado pelo médico assistente do autor, o qual é conhecedor das peculiaridades do seu quadro clínico, além de o medicamento estar previsto no Rol da ANS, ainda que para patologia distinta (câncer de pulmão), reputando-se absolutamente indevida eventual interpretação restritiva das diretrizes de utilização.

Sinale-se que as diretrizes da ANS não devem ser interpretadas de forma restritiva, mas sim de forma ampla, notadamente por haver laudo médico prescrevendo e atestando o tratamento como alternativa à redução da progressão da doença do demandante.

Destaca-se, também, que o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com indicação para o tratamento de Fibrose Pulmonar, conforme se extrai da bula eletrônica (Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=103670173) e do parecer emitido pela ANVISA e pela Superintendência de Medicamentos e Produtos Biológicos (SUMED) para registro do fármaco no país (Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=OFEV).

Outrossim, é entendimento do STJ que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que receberão cobertura, **mas não o tipo de tratamento**, consoante se extrai do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

> *A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde.* ***De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.*** *Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02).* ***Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.*** *Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção.* ***O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa.*** ***É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica.*** ***Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.*** *Assim, no caso, não havendo exclusão do câncer na apólice do autor, não há como impedir a cobertura do seguro para o tratamento por quimioterapia em regime ambulatorial ou de internação.*[2] ***(grifei)***

No caso dos autos, tenho que a imprescindibilidade da utilização do medicamento pelo autor está devidamente comprovada nos autos, sendo que o não uso do fármaco acarreta, até mesmo, risco de óbito ao requerente. Veja-se, nesse sentido, o teor do laudo médico acostado ao evento 23-LAUDO2:

LAUDO MÉDICO

Atesto para fins de obtenção de medicamento de alto custo, que o paciente Sérgio Pedro Goettert faz acompanhamento médico por ser portador(a) de patologia classificada no CID-10 com o código J84.1 (Outras Doenças Pulmonares Intersticiais com Fibrose - Fibrose Pulmonar Idiopática). Apresenta distúrbio ventilatório restritivo, progressão sintomática recente, dispneia (falta de ar) aos mínimos esforços e piora da qualidade de vida. Necessita uso contínuo do medicamento nintedanibe (Ofev®), na dose de 150 miligramas (mg) duas (02) vezes ao dia (uso contínuo – 60 comprimidos por mês), devendo ser iniciado com urgência e mantido por tempo indeterminado.

Essa medicação é a recomendada por ampla literatura médica para o tratamento do paciente, não tendo outra alternativa terapêutica para sua moléstia que não esse medicamento. Com sua administração contínua, o paciente poderá apresentar arrefecimento no curso de sua doença e redução do risco de exacerbações da mesma, sendo que na vigência desta última condição o paciente tem risco elevado de consequências graves, inclusive óbito. É somente com o uso contínuo de tal medicação, que poderemos observar o benefício esperado da mesma.

Declaro ainda que não possuo qualquer interesse na prescrição do medicamento que não o tratamento da saúde do paciente, bem como não mantenho qualquer vínculo com a indústria farmacêutica.

Referências:

1. Richeldi L, Costabel U, Selman M, Kim DS, Hansell DM, Nicholson AG, Brown KK, Flaherty KR, Noble PW, Raghu G, Brun M, Gupta A, Juhel N, Klüglich M, du Bois RM. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2011;365(12):1079.
2. Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, Azuma A, Brown KK, Costabel U, Cottin V, Flaherty KR, Hansell DM, Inoue Y, Kim DS, Kolb M, Nicholson AG, Noble PW, Selman M, Taniguchi H, Brun M, Le Maulf F, Girard M, Stowasser S, Schlenker-Herceg R, Disse B, Collard HR, INPULSIS Trial Investigators. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014;370(22):2071.
3. Wollin L, Wex E, Pautsch A, Schnapp G, Hostettler KE, Stowasser S, Kolb M. Mode of action of nintedanib in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J. 2015 May;45(5):1434-1445.
4. Laurenson S, Sidhu R, Goodall M, Adler AI. NICE guidance on nintedanib for treating idiopathic pulmonary fibrosis. Lancet Respir Med. 2016;4(3):176.

Rui Gustavo Dorneles
Clínica Médica - Pneumologia
Endoscopia Respiratória
CREMERS 34913

Dr. Rui Gustavo Dorneles
CREMERS 34913
Médico Pneumologista

Santa Cruz do Sul, 31 de janeiro de 2023.

Outrossim, realizada audiência de instrução, foi inquirida a testemunha, Dr. Rui Gustavo Dorneles, médico que acompanha o autor, oportunidade em que o mesmo esclareceu os motivos técnicos e científicos que levaram à prescrição do fármaco. Sustentou que o medicamento em questão é indicado para a doença que acomete o autor. Salientou que durante o período em que o autor fez uso do medicamento, apresentou significativa melhora, porém com a suspensão do mesmo, teve uma piora em seu quadro, necessitando, inclusive, de internações hospitalares. Asseverou que não há outro medicamento, que possa ser usado pelo autor, para evitar a progressão da doença, sendo que para o diagnóstico do mesmo, o remédio prescrito é a opção existente para conter a evolução da patologia que lhe acomete.

De todo o exposto, entendo que se mostra descabida e abusiva a negativa de fornecimento do fármaco, porquanto o que deve prevalecer é a existência de previsão para cobertura à enfermidade, e não a forma como ele deve ser ministrado, cabendo somente ao médico que assiste o segurado, e não à seguradora, a eleição do tratamento.

Ainda na mesma linha do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito transcrito acima, certo é que o médico que assiste, que acompanha e que tem contato direito com o paciente é, sem dúvida, aquele que pode prescrever o tratamento de saúde mais adequado ao seu estado clínico, motivo pelo qual o tratamento em tela deve ser considerado como legítimo e passível de cobertura pela demandada.

Dessa forma, não há como afastar a obrigação da ré em fornecer o tratamento e a medicação pleiteada pela parte autora através da presente demanda.

Sobre o tema, assim também se posiciona a jurisprudência do egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RAZÃO DA INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA FINANCEIRA DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 2. ***Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.*** *Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com a imposição de multa. (AgRg no REsp 1450673/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014)*

No mesmo sentido, em casos semelhantes à situação posta nos autos, é a jurisprudência do TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ***PLANO DE SAÚDE****. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.* ***FIBROSE PULMONAR. OFEV (NINTEDANIBE). ANTINEOPLÁSICO ORAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO****. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 3. No ponto, cumpre destacar que, conforme jurisprudência desta c. Câmara Cível, o rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, não possuindo caráter taxativo, o que foi*

ratificado pela inclusão do §12 no art. 10 da Lei nº 9.656/98. 4. Não obstante o caráter exemplificativo do Rol da ANS, o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais, das medicações em regime de home care e dos incluídos no rol da ANS. 4. ***No presente caso, tem-se como devida a cobertura postulada, sobretudo porquanto concernente a medicamento recomendado pela médica assistente, conhecedora das peculiaridades do quadro clínico do autor, e previsto no Rol da ANS, ainda que para patologia distinta (câncer de pulmão), reputando-se absolutamente indevida eventual interpretação restritiva das diretrizes de utilização.*** *5. Outrossim, entre as exigências mínimas previstas na Lei está a cobertura de tratamento antineoplásicos domiciliares de uso oral, segmento no qual se inclui o medicamento Nintedanibe, conforme consta de seu registro na ANVISA. E, estando o medicamento incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadra-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde. 6. De qualquer sorte, nos termos do § 13, inciso I, do art. 10 da Lei n° 9.656/98, é possível a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 6.* ***In casu, o medicamento postulado é tratamento eficaz para a patologia que acomete a parte autora (fibrose pulmonar), à luz da medicina baseada em evidências. Ainda, destaca-se que o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com indicação para o tratamento de Fibrose Pulmonar, conforme consta na bula. Além disso, há diversas notas notas técnicas extraídas do sistema e-NatJus favoráveis ao tratamento****. 5. De consequência, com fulcro no §11 do artigo 85 do CPC, restam majorados os honorários devidos pela parte ré aos procuradores da parte autora. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 51456679820228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-10-2023)*

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. ***PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA.*** *SENTENÇA REFORMADA. I.* ***NO PRESENTE CASO, A AUTORA PRETENDE VER RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM COBRIR OS CUSTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV) - 150 MG, EM RAZÃO DE QUADRO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10 J84.1).*** *II. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. III. É LÍCITA A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DA UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS, A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM, NA FORMA DOS ARTS. 10, VI, E 12, I, "C", E II, "G", DA LEI N° 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ. IV. CONFORME SE EXTRAI DA BULA DO MEDICAMENTO OFEV (NINTEDANIBE), O FÁRMACO EM QUESTÃO É INDICADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO, ESTANDO INCLUÍDO NA CATEGORIA DE ANTINEOPLÁSICOS, TENDO SIDO INSERIDO NO ROL DA ANS ATRAVÉS DA RN Nº 465/2021 QUE DISPÕE SOBRE O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE NO ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. V.* ***APESAR DE O MEDICAMENTO TER SIDO INSERIDO NO ROL DA ANS QUANDO INDICADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO, A EXISTÊNCIA DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, PORQUANTO OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE.*** *VI. TAMBÉM, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, OU RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. VII. NO CASO, HÁ NOTA TÉCNICA DA PLATAFORMA E-NATJUS (NOTA TÉCNICA 146392) FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE EM PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, COMO É O CASO DA AUTORA. VIII. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50042000720228210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-07-2023)*

Destarte, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer que SERGIO PEDRO GOETTERT move em face de UNIMED NACIONAL, para DEFERIR a tutela de urgência e DETERMINAR que a ré forneça a medicação Nintedanibe (Ofev) 150 mg, nos exatos termos da indicação médica, na quantidade indicada pelo médico, pelo período que se fizer necessário, de acordo com a avaliação exclusiva do médico assistente do demandante.

Face o deferimento da tutela de urgência, a ré deverá proceder ao fornecimento do medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, que estabeleço em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, considerando a natureza da ação e o trabalho desenvolvido, atualizado pelo IGP-M a partir desta data, bem como acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Sentença publicada e registrada pelo sistema.

Partes intimadas eletronicamente.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa eletrônica.

1Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

2Resp 668216/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 15.03.2007.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA BERNARDES DA SILVA, Juíza de Direito**, em 30/10/2023, às 19:3:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10048954750v2** e o código CRC **7a455844**.